

ניתוח הדרדרות לאומי בקצבת סיעוד

מעברי רמות גמלה - תובנות, דפוסים וסייגים

פברואר 2026

שני מקורות נתונים:

מקור א: 'כלל מעברי רמה נוב' 2018 - אוג' 2025 - 113,925 מעברים
מקור ב: 'החלטות זכאות 2025 שבהן הוגדלה רמה - 56,450 החלטות

תקציר מנהלים

ניתוח של 113,925 מעברי רמות גמלה ו-56,450 החלטות 2025 חושף ארבעה דפוסים מערכתיים. הממצאים מבוססים על פערים יחסיים בתוך הנתונים ולא על השוואה בין תקופות.

ארבעה ממצאים מרכזיים

#	ממצא	משמעות ניהולית
1	פער מגדרי עקבי	נשים ממתירות 4.9 חודשים יותר מגברים בממוצע (20-24%) - בכל רמת גמלה, בכל סוג מעבר, ובכל גודל קפיצה. דפוס מערכתי עקבי.
2	אפקט גיל דרמטי	בני +85 שוהים 10.2 חודשים יותר מבני עד 74. אינטראקציה גיל-מגדר: נשים +85 ברמה 1 = 40.3 חודשים, גברים עד 74 = 19.9. פער 2x.
3	סל שירותים חד-ממדי	72% מכלל המעברים (2018-2025) צרכו סוג שירות אחד בלבד. 44.6% מרמה 1 לא קיבלו שום שירות לפני המעבר. (סייג: אין קבוצת ביקורת.)
4	37% קפיצות חריגות	42,213 מקרים עוברים +2 רמות בבת אחת. 13.7% קפצו +3 רמות. הקפיצות מהירות יותר (14.3 חודשים vs 16 הדרגתי) - הדרדרות מואצת בלתי מזוהה.

1. פערי מגדר - דפוס מערכתי עקבי

הפער המגדרי הוא הממצא החזק ביותר בנתונים: הוא עקבי בתוך שני המקורות, בכל רמה, בכל סוג מעבר, ובכל חתך. מאחר שההטיית שרידות משפיעה באופן שווה על גברים ונשים, הפער היחסי ביניהם תקף לחלוטין.

שהות ממוצעת לפי רמת מוצא ומגדר) מקור ב' - 2025, חודשים)

רמה	גברים	נשים	פער	פער %	יחס נ:ג	מקרים
1	28.6	32.3	3.7	13%	1.82	17,871
2	24.0	29.0	5.0	21%	1.57	20,301
3	24.4	30.3	5.8	24%	1.44	10,591
4	24.9	30.5	5.6	22%	1.59	6,212
5	22.5	26.9	4.4	19%	1.10	1,475

תובנות:

- הפער הגבוה ביותר ברמה 3 (5.8 חודשים, 24%) - נשים ברמת סיעוד 3-5 שוהות הרבה יותר מגברים.
- הפער קיים גם בחציון (5.6 חודשים) - לא מדובר בערכים קיצוניים שמושכים את הממוצע.
- נשים מהוות 61.6% מכלל המקרים - הנפגעות העיקריות.

הפערים הגדולים ביותר לפי סוג מעבר (מקור ב' 5)

מעבר	גברים	נשים	פער (חודשים)	מקרים
4→1	31.8	38.4	6.6	616
5→3	23.3	29.5	6.3	2,205
5→1	30.1	36.1	6.0	474
3→2	24.2	30.0	5.7	13,263
4→3	25.2	30.9	5.7	5,935

2. אפקט גיל - ככל שמבוגרים יותר, שוהים יותר

הגיל הוא המנבא החזק ביותר לאורך השהות. גם כאן, הפער היחסי בין קבוצות הגיל תקף מאחר שההטיה משפיעה באופן דומה על כל הגילאים.

שהות ממוצעת לפי גיל ורמת מוצא(מקור ב' - 2025, חודשים)

גרדיאנט	מקרים +85	+85	75-84	עד 74	רמה
14.5+ (60%)	4,240	38.5	30.9	24.0	1
9.4+ (43%)	6,512	31.1	26.7	21.7	2
11.0+ (54%)	5,565	31.6	24.7	20.5	3
10.3+ (50%)	3,774	30.9	25.4	20.6	4
5.6+ (26%)	648	26.8	24.0	21.2	5

תובנות:

- ברמה 1, בני +85 שוהים 14.5 חודשים יותר מבני עד 74 - פער של 60%.
- קבוצת 75-84 היא הגדולה ביותר (44.5%) - מרכז הכובד של המערכת.
- ברמה 5 הגרדיאנט נמוך יחסית (26%) - כשההדרדרות ברורה, הגיל פחות משפיע.

מגדר - הפרופיל הקיצוני רמה 1, (מקור ב א אינטראקציה גיל)

פרופיל	מקרים	ממוצע	חציון	שנים	יחס לבסיס
גברים עד 74	1,315	19.9	16	1.7	1.0 (בסיס)
נשים 75-84	3,249	25.7	22	2.1	x1.29
גברים +85	3,220	27.9	25	2.3	x1.40
נשים עד 74	5,847	32.6	30	2.7	x1.64
גברים 75-84	1,800	36.1	35	3.0	x1.81
נשים +85	2,440	40.3	41	3.4	x2.03

- נשים +85 שוהות פי 2 מגברים צעירים - שילוב גיל + מגדר מכפיל את הפער.

3. דפוסי מעבר - 37% קפיצות

ניתוח 113,925 מעברים (מקור א') חושף שיותר משליש עוברים +2 רמות בבת אחת. הערה: אי אפשר לדעת מתוך הנתונים האם מדובר בהדרדרות שלא זוהתה או בהדרדרות מהירה בפועל - נדרשים נתונים על תדירות הערכות.

התפלגות לפי גודל קפיצה(מקור א')

רמות שינוי	מקרים	אחוז	ממוצע שהות	חציון	הערה
1	71,712	62.9%	16.0	13	הדרגתי
2	26,623	23.4%	15.8	12	
3	12,495	11.0%	14.3	10	קפיצה
4	2,676	2.3%	14.5	11	
5	419	0.4%	16.3	12	1→6

מעברים נפוצים (מקור א')

מעבר	מקרים	% מסה"כ	ממוצע שהות	חציון	הערה
4→3	22,493	19.7%	16.9	14	נפוץ ביותר
3→2	21,424	18.8%	15.5	12	
5→4	10,789	9.5%	16.6	13	
6→5	10,316	9.1%	15.3	12	
6→4	10,208	9.0%	15.0	11	קפיצה
6→3	8,544	7.5%	14.2	10	קפיצה

תובנות:

- מעבר 3→4 הנפוץ ביותר (22,493 = 19.7%). צוואר בקבוק: רמה 3 היא 'תחנת מעבר' מרכזית.
- קפיצות +3 רמות מהירות יותר (14.3 חודשים) ממעברים הדרגתיים (16.0) - ייתכן הדרדרות מואצת, ייתכן זיהוי מאוחר.
- מרמה 1: 53.8% עוברים ל-2, אך 14.8% קופצים ישיר ל-4/5/6.

4. צריכת שירותים - תמונה חלקית

ניתוח השירותים מתבסס על מקור א' (2018-2025). סייג מרכזי: הנתונים כוללים רק את מי שעבר רמה. ללא קבוצת ביקורת (מי שנשאר באותה רמה) אי אפשר לקבוע שמיעוט שירותים גורם להדרדרות - ייתכן שזו מאפיין של אוכלוסייה מסוימת.

מגוון שירותים לפני מעבר רמה (מקור א')

רמה	0 שירותים	שירות 1	2 שירותים	+3 שירותים	סה"כ מקרים
1	44.6%	51.3%	3.8%	0.3%	12,443
2	4.9%	82.5%	11.4%	1.1%	33,082
3	5.2%	73.5%	18.2%	3.1%	37,087
4	7.1%	68.0%	21.1%	3.7%	20,997
5	10.4%	63.1%	22.2%	4.3%	10,316

אחוז מקבלי שירות לפי סוג (מקור א')

רמה	טיפול אישי	מרכז יום	מוצרי ספיגה	משדר מצוקה	כביסה	קהילה
1	53.2%	1.7%	2.3%	2.0%	0.0%	0.7%
2	93.2%	3.6%	5.8%	4.7%	0.1%	1.2%
3	93.4%	5.1%	10.8%	8.1%	0.2%	1.8%
4	90.6%	4.3%	15.6%	9.7%	0.2%	1.2%
5	86.4%	4.6%	19.0%	9.1%	0.2%	1.3%

תצפיות (לא מסקנות סיבתיות):

- 44.6% מרמה 1 ללא שירותים – בשל זכאות לגמלה מליאה בכסף ביחס המרה של 100%
- הסל חד-ממדי: 72% צרכו סוג אחד בלבד. טיפול אישי שולט; שאר השירותים שוליים.
- מוצרי ספיגה עולים עם הרמה (2.3%→19%) - קורלציה עם חומרה, אך אינה מנבאת.
- שירותי קהילה תומכת שוליים (0.7%-1.8%) - שאלה: האם הרחבתם תשנה דפוסים?
- לבדיקה: השוואה מול קבוצת ביקורת (זכאים שלא עברו רמה) כדי לקבוע סיבתיות.

5. המלצות

#	המלצה	פירוט	עדיפות	אופק
1	ביקורת מגדרית	בדיקה מערכתית של תהליכי הערכה: האם כלי ההערכה מוטים? האם תדירות הבדיקות שונה? הפער של 4.9 חודשים הוא עובדה - הסיבה דורשת חקירה.	קריטי	Q1-Q2
2	פרוטוקול גיל +85	מעקב יזום עם תדירות בדיקה מוגברת לבני +85. פער של +10 חודשים מצדיק התייחסות ייעודית.	קריטי	Q1
3	השלמת נתונים	בקשה מהאנליסט: (א) קבוצת ביקורת לשירותים, (ב) פילוח גיאוגרפי/ספק, (ג) תדירות הערכות, (ד) הגדרת יחידת זמן לשיעורי מעבר.	גבוה	Q1
4	ניתוח קפיצות	חקירת 15,590 מקרי קפיצה (+3 רמות): האם הדרדרות מואצת או כשל זיהוי? נדרש ניתוח תהליכי הערכה.	גבוה	Q2
5	דשבורד מעקב	הקמת דשבורד עם פילוח מגדר/גיל/שירותים. מדדים מוצעים: מדד שהות יחסית ומדד מגוון שירותים (ראה מסמך מדדים).	בינוני	Q2
6	בחינת סל שירותים	ניתוח כדאיות הרחבת שירותי מניעה (קהילה, מרכזי יום) - מותנה בהשלמת קבוצת ביקורת.	בינוני	Q3

הערה מתודולוגית חשובה

הדוח מבוסס על שני מקורות נתונים שונים במהותם, ויש לקרוא אותם בנפרד:

- מקור א' (קובץ מעברי רמות, 2018-2025): כולל את כלל 113,925 המעברים שבוצעו מאז הרפורמה. שהות ממוצעת: 15-17 חודשים. כולל נתוני שירותים.
 - מקור ב' (החלטות 2025): כולל 56,450 החלטות שהתקבלו ב-2025 בלבד. שהות ממוצעת: 24-32 חודשים. מפורט לפי מגדר, גיל, ושילובם.
- הפער בשהות בין המקורות (16 לעומת 28 חודשים) אינו מעיד על הידרדרות המערכת. מדובר בהטיית שרידות (Survivorship Bias): מי שהחלטה התקבלה ב-2025 הוא בהגדרה מי ששהה ברמה זמן ארוך יותר - כי מי שהיה צריך לעבור מהר כבר עבר בשנים קודמות. ככל שהרפורמה מתבגרת, קצבי המעברים כוללת יותר 'שוהים ארוכים'.

סייגים נוספים (מהאנליסט):

- לא ניתן להסיק מהנתונים על הסתברות מעבר לרמה גבוהה יותר - לא כל הזכאים עוברים רמה כלל.
 - יחידת הזמן לבדיקת שיעורי מעבר טרם נקבעה - ולה השפעה מהותית על התוצאות.
 - נתוני השירותים חסרים קבוצת ביקורת (מי שלא עבר רמה) - אי אפשר לקבוע סיבתיות.
- לפיכך, הניתוח מתמקד בפערים יחסיים בתוך כל מקור בנפרד (מגדר, גיל, סוג מעבר) - שאינם מושפעים מההטייה.

מה אי אפשר לומר מהנתונים

- אי אפשר להשוות שהות 2025 לשהות היסטורית - הטיית שרידות.
- אי אפשר לקבוע שמיעוט שירותים גורם להדרדרות - אין קבוצת ביקורת.
- אי אפשר לחשב שיעורי מעבר (הסתברות) - אין מכנה (כלל הזכאים).
- אי אפשר לפלח לפי גיאוגרפיה, ספק, או מצב רפואי - חסרים שדות.